

2025 г

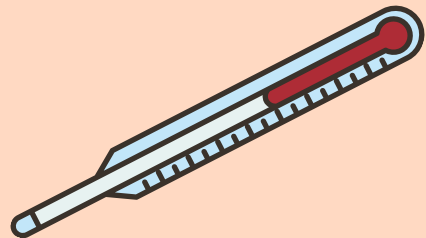
Уверенность в каждом шаге

Практические советы и алгоритмы



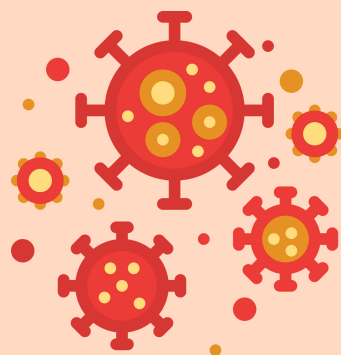
Автор : врач общей практики
Маерманова Индира

Температура и жаропонижающие



- Что считается нормой
- Как рассчитать дозу жаропонижающего
- Когда сбивать температуру , а когда не стоит
- Ошибки при сбивании температуры
- Судороги на фоне температуры. Что делать в таких случаях.

Частые болезни и состояния



- Желтуха новорожденных: когда норма, а когда патология
- Кандидозный стоматит и пеленочный дерматит
- Сыпь у детей: опасная и безобидная
- Кашель и насморк : алгоритм действий для мамы
- Когда нужно срочно обратиться к врачу

Питание и ЖКТ



- Срыгивания и колики . Как отличить норму от патологии
- Запоры и диарея.
- Аллергия на питание . Как заподозрить.
- Расчет питания . Введение прикорма

Вакцинация



- Зачем нужна вакцинация и как подготовиться
- Реакции на прививки: норма и опасность
- Что делать , если ребенок заболел перед вакцинацией

Физическое и психоэмоциональное развитие



- Нормы развития по месяцам
- Красные флаги развития

Экстренные ситуации



- Первая аптечка для ребенка
- Что делать при удушье
- Аллергическая реакция (от крапивницы до анафилаксии)
- Ушибы, падения , ожоги

Грудное вскармливание



- Как понять хватает ли ребенку молока.
- Положение при кормлении
- Трещины, лактостаз, мастит .

Взаимодействие с врачами

- Что спросить у врача



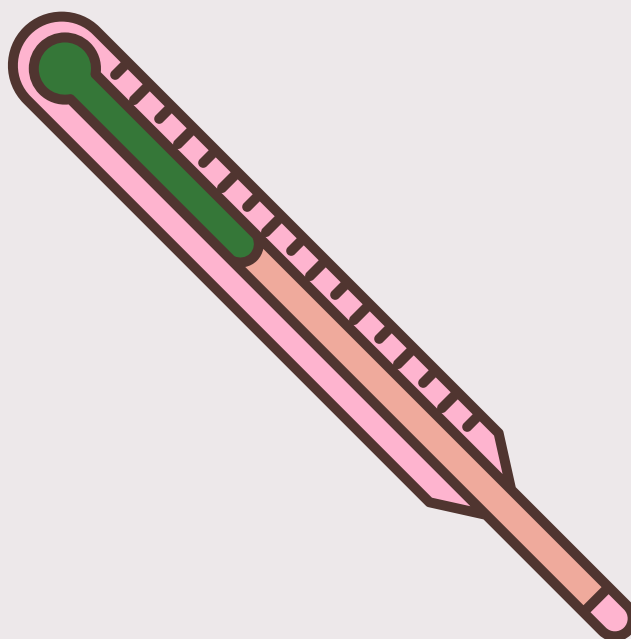
Сон ребенка и отдых мамы

- Нормы сна по возрасту
- Как наладить режим сна



Что считается нормой?

- У детей до 1 года температура до 37,5 - не повод для паники
- После вакцинации возможно повышение до 38- это нормально
- У грудничков до 3 мес- любое повышение=обращение к врачу

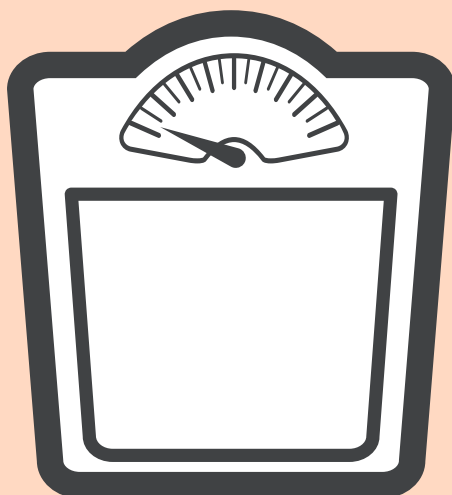


Как рассчитать дозу жаропонижающего?



Ибупфен 100 мг/5 мл
Ибупфен 200 мг/ 5 мл

Разовая доза препарата Ибупфен® Д Форте составляет 5-10 мг/кг массы тела ребенка



Пример : если ребенок весит 10 кг,
следовательно $10 * 10 = 100$ мг

Подключаем математику 😊

200 мг - 5 мл

100 мг - x мл , отсюда $x = 100 * 5 / 200$

$x = 2,5$ мл (разовая доза)

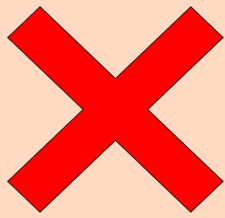
Давать через рот не чаще, чем 1 р
в 6 ч.

Парацетамол (Панадол сироп 120 мг / 5 мл)

Возраст ребенка	Разовая доза, мл	Частота приема (в течение 24 часов)
3-6 месяцев	2,5 мл	4 раза
6-24 месяцев	5 мл	4 раза
2-4 года	7,5 мл	4 раза
4-8 лет	10 мл	4 раза
8-10 лет	15 мл	4 раза
10-12 лет	20 мл	4 раза

Когда сбивать температуру ?

до 38 гр	Обильное питье, проветривать помещения, наблюдать
от 38 гр	Если ребенок вялый, не играет , плохо ест -дать жаропонижающее
от 38,5	Давать обязательно
от 39,5	Вызвать врача



Что нельзя делать ?

- Обтирать уксусом или спиртом
- Укутывать
- Чередовать жаропонижающие без указания врача
- Паниковать , если у ребенка 38, но он активный

Когда срочно к врачу ?



- Температура не снижается в течение 3 часов и более
- Судороги , рвота, сыпь
- Ребенок не реагирует , не берет грудь
- Температура выше 39,5

Фебрильные судороги

ответная реакция организма ребенка на резкий подъем температуры (обычно выше 38,5-39)

Как это выглядит

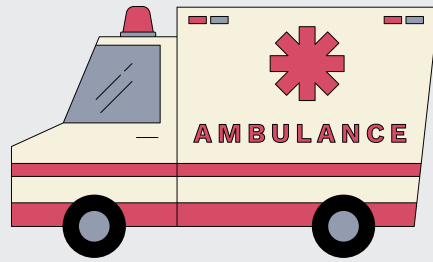


Вдруг на фоне высокой температуры ребенок вдруг замирает, откатывает глаза, дергается, может быть судорога всего тела или конечностей, может потерять сознание на 1-2 мин.

Что делать маме:

- не паниковать
- положить ребенка на бок на ровную поверхность
- ничего не ложить ребенку в рот
- отметить время судороги
- по окончании судорог дать жаропонижающее

Срочно вызывать скорую, если :



- Судороги длятся больше 5 минут
- повторились в течение суток
- ребенок не приходит в себя более 10 минут

Профилактика:

- Снижать температуру с 38-38,5 , особенно если судороги уже были
- Давать жаропонижающее вовремя
- Не перегревать ребенка
- Исследования показывают прямую связь между дефицитом витамина Д и возникновением фебрильных судорог

Желтуха новорожденных.

Когда норма, а когда патология.

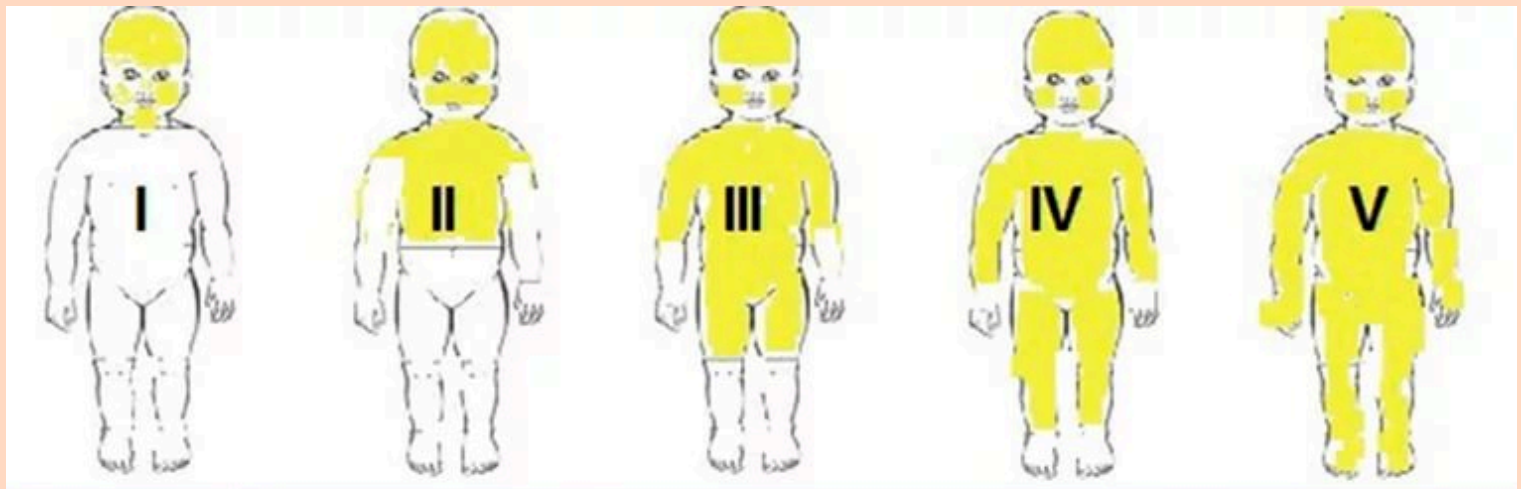
- Физиологическая желтуха (норма)
появляется на 2-3 день жизни
- Постепенно уходит сама к 10-14 дню.
- Ребенок активный, сосет грудь , мочится и испражняется как обычно

Что делать маме:

- Чаще прикладывать к груди
- Следить за питьем и стулом малыша

Когда это тревожный сигнал ?

- Появилась в первые 24 часа жизни
- Желтизна быстро усиливается и распространяется по всему телу
- Держится больше 2 недель
- Сопровождается вялостью, отказом от груди , судорогами ребенка
- Моча становится темной, а кал обесцвеченным



Степень желтухи	Желтушные участки кожи	Уровень билирубина мкмоль/л
I	Лицо, шея.	>80
II	Лицо, шея, спина, грудь, живот до пупка.	150
III	Вся кожа до локтевых сгибов и колен.	200
IV	Всё тело, кроме кожи на ладонях и подошвах.	>250
V	Всё тело	>350

Кандидозный стоматит (молочница)

воспаление слизистой оболочки полости
рта

белые “творожистые” налеты на языке,
деснах, небе.

- Часто возникает у детей первого года жизни
- Ребенок может быть беспокойным, отказываться от груди / бутылочки (в связи с болезненностью)

Что делать маме:

- Кормление грудью и обильное питье для увлажнения слизистой
- Обезболивание -ибупрофен или парацетамол
- теплая мягкая пища в виде пюре
- полоскание рта водой или солевыми растворами

Пеленочный дерматит



--раздражение кожи в области под подгузником из-за контакта с мочой, калом или повышенной влажности и трения

Когда это норма ?

- если покраснения небольшие и проходят при уходе
- ребенок спокоен , не беспокоится

Когда стоит встревожиться?

- сильные покраснения , участки мокнутия
- белый налет или ярко-красные пятна
- долго не уходит при уходе
- ребенок капризный, плачет при соприкосновении с кожей

Что делать маме:

- Менять подгузник каждые 2-3 часа
- Давать малышу “воздушные ванны” по 10-15 минут несколько раз в день
- Чаще подмывать просто теплой водой
- Использовать “барьерные” средства под подгузник(с цинком или пантенолом)
- Подбирать подгузники по размеру

Когда обратиться к врачу :

- Если появилась сыпь с гноем, пузырьки
- Если повышается температура у ребенка
- Если есть грибковое поражение (налет)

Сыпь у детей и пограничные состояния кожи



Когда норма?

- У новорожденных токсическая эритема (рис. 1) на 2 сутки жизни) красные пятна размером 2-3 мм на лице, туловище и конечностях. Лечение не требует.
- Акне новорожденных (рис 2) - белые или красноватые прыщики на лице, проходит к 3-4 мес жизни, лечение не требуется.



рис 1



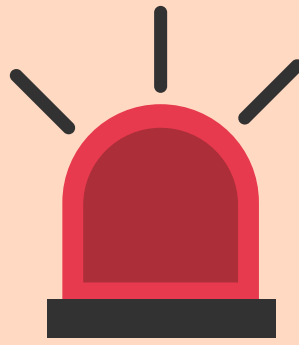
рис 2

- Милиумы-маленькие кисты сальных желез, бывают на переносице, подбородке, под глазами(рис 3)
- Постнатальная десквамация(сильное шелушение кожи , адаптирование к условиям окр среды)рис 4)

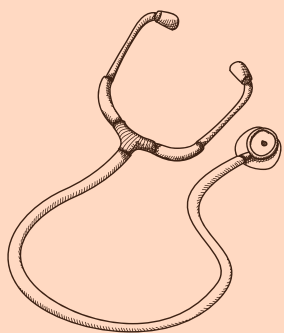


Причина	Как выглядит	Что делать
Потничка	мелкая, розовая, на шее, спине, складках	Проветривать, ванночки с ромашкой
Аллергия (пищевая/ контактная)	красные пятна, может чесаться, нет температуры	Исключить аллерген , наблюдать , внутри можно капли Фенистил (2 капли на кг массы тела , деленное на 3 приема)
После температуры/ вируса	мелкая, розовая, появляется на 3-5 день болезни , ребенок уже активен	это “розеола”, пройдет сама

Красные флаги



- Сыпь не исчезает при нажатии
- Одновременно с высокой температурой, рвотой, судорогами, слабостью
- Петехии- маленькие точки, как уколы иглой
- Сыпь появляется внезапно и быстро распространяется
- Есть отеки губ, языка, затрудненное дыхание



Что может назначить врач:



Общий анализ крови



Аллергопробы (если повторы сыпи)

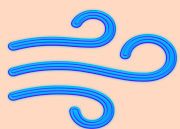


При необходимости госпитализация ,
если вдруг менингококковая инфекция

Кашель - это симптом , а не болезнь, он помогает организму очищать дыхательные пути

<u>Тип</u> <u>кашля</u>	<u>Как звучит</u>	<u>Что может</u> <u>быть</u>
Сухой	без мокроты, навязчивый	орви , начало болезни
Мокрый	с мокротой, “булькает “	восстановление, бронхит
Лающий	грубо, как у собаки	ларингит
Приступообразный	внезапно, долго не проходит	коклюш, аллергия

Что делать при кашле:



Проветрить помещение,
увлажнить воздух



Обильное питье-
помогает разжижать мокроту



Не заставлять лежать - движение
помогает откашляться



Не давать сироп “на всякий
случай”



Когда нужны лекарства ?

- Если сухой и мучительный - только по назначению врача
- Отхаркивающее - при влажном кашле
- Не давать противокашлевые и отхаркивающие одновременно

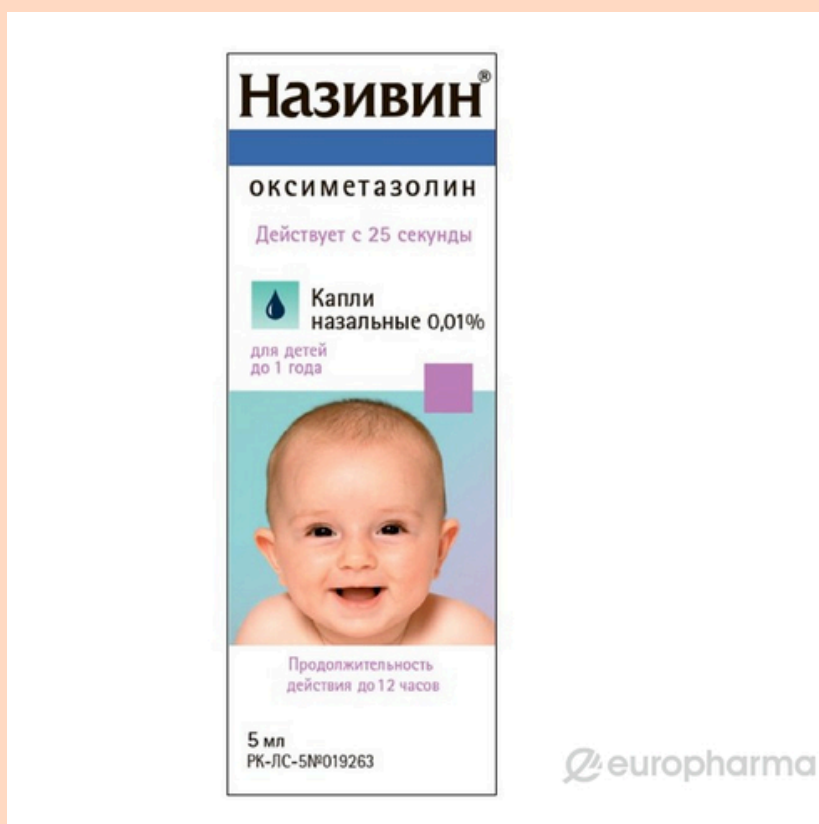
Когда срочно к врачу?

- Кашель мешает дышать
- Ребенок посинел, втягивает ребра
- Температура 38,5 и выше, держится больше 3 дней
- Кашель + осипший голос, свист - возможен стеноз

Насморк так же защитная реакция организма, поэтому не стоит сразу паниковать , значит организм хорошо справляется с инфекцией.

Как справляться маме ?

1. Создать оптимальные комфортные условия в комнате , где находится малыш (температура воздуха 20-22 гр, опт влажность 60%).
2. Использовать изотонические солевые растворы для промывания носовой полости
3. Обязательно иметь дома назальный аспиратор для отсасывания слизи из носа
4. Использовать сосудосуживающие капли только в крайних случаях(например , Називин)



Срыгивание- перемещение содержимого из желудка в пищевод, а иногда - через рот или нос.

Начинаются примерно на 2-3 неделе жизни. По мере созревания верхних отделов пищеварительного тракта они начинают угасать к 5-6 мес , а к 9-12 мес бесследно проходят

Что способствует угасанию?

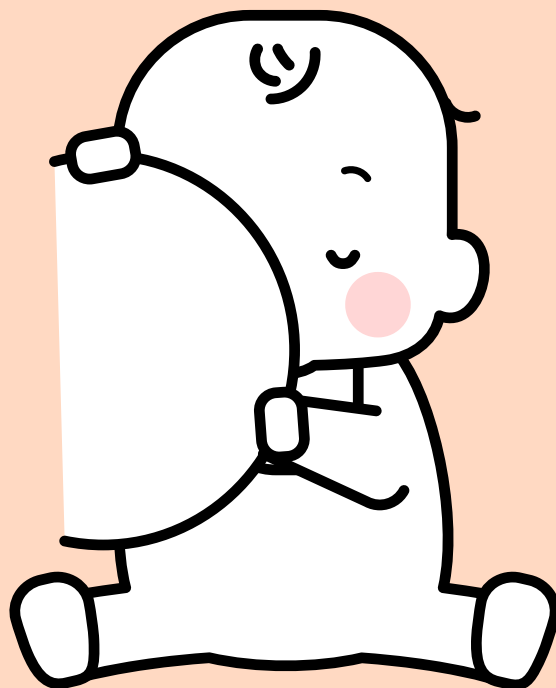
- Ребенок научился держать голову
- научился сидеть
- пришло введение твердой пищи



- Отказ от еды или груди
- Плачет во время кормления
- Непонятный цвет при срыгивании
- Твердый на ощупь или раздутый живот
- Любые дыхательные нарушения
- Срыгивание перешло во рвоту /рвоту фонтаном

Как помочь малышу?

- После кормления держать ребенка в вертикальном положении
- Избегать перекармливания
- Обсудить с врачом схемы кормления
- Можно попробовать антирефлюксные или антиколиковые бутылочки



Признаки колик



- Непрекращающийся плач
- Вздутый, твердый живот
- Сжатые кулачки
- Поджатые к животу ножки
- После отхождения газов или стула ребенку становится легче

Что может помочь маме и малышу:

- Контакт “живот к животу”, ношение на руках в позах “тигр на ветке” (рис 1), просто высаживания (рис 2), “поза Будды” (рис 3)
- теплые пеленки снимают спазм
- массаж живота по часовой стрелке
- кормление по требованию (не перекармливать)
- Пробиотики, Симетикон



ПОЗА ТИГР НА ВЕТКЕ Рис 1



Рис 2



Рис 3



Когда это не колики!

- Обязательно обратиться врачу, если :
- плач сопровождается температурой , рвотой
- В кале есть слизь или кровь
- Ребенок плохо набирает в весе
- Плач не устраняется никакими методами успокоения

Диарея у ребенка

Обратить внимание на общее состояние ребенка (беспокоен , вялый или активен), есть ли запавшие глаза, пьет с жадностью или , наоборот, не хочет пить , как расправляется кожная складка)



так оценим степень обезвоживания

Классификация БОЛЬНОГО ребенка по ДИАРЕЕ !!!

Два или более из следующих признаков: Летаргичен или без сознания Запавшие глаза Не может пить или отказывается от питья Кожная складка расправляется очень медленно	ТЯЖЕЛОЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ
Два или более признаков: •Беспокоен, раздражителен •Запавшие глаза •Пьет жадно, жажда •Кожная складка расправляется медленно.	УМЕРЕННОЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ
Недостаточно признаков, чтобы классифицировать умеренное или тяжелое обезвоживание.	НЕТ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ

Воспользуйтесь буклетом-схемой и определите классификацию этого ребенка по диарее!

Если у ребенка диарея в течение 14 и более дней, а также УМЕРЕННОЕ или ТЯЖЕЛОЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ, классифицируется состояние ребенка как ТЯЖЕЛАЯ ЗАТЯЖНАЯ ДИАРЕЯ.

Ребенка следует направить в стационар.

Есть ли кровь в стуле ?



При отсутствии обезвоживания лечим ребенка на дому:



Поить : регидрон

- Малышу до года- 50 - 100 мл после каждого жидкого стула
- старше года- 100- 200мл



Грудное молоко не отменять



Кормить легко: рис, бана, яблоко , сухари



Исключить соки , сладкое,
жирное, молочное

К врачу , если :

- Ребенок вялый, не пьет , не сосет грудь
- Стул с кровью
- Температура выше 38,5
- Диарея больше 3 дней
- Возраст до 3 мес

Запор у детей

Что делать дома:

- Младенцу продолжать ГВ, сделать массаж живота по часовой стрелке
- старше 6 мес : добавить пюре из чернослива , сухофруктов
- Больше двигательной активности , больше жидкости

Почему горшок = причина запоров

- Страх и боль : если ранее ребенок испытывал проблему дефекации : твердый кал, анальная трещина -он начинает удерживать стул , боясь повторения боли
- Насильное приучение родителями : ребенка сажают насильно , держат долго на горшке , у ребенка формируется стресс , отсюда запор

- Проблемы с режимом :
его отвлекают , торопят , горшок
неудобный, холодный, не нравится

Что делать маме :

- не ругать
- давать ребенку контроль “ когда
захочешь-скажи
- делать атмосферу на горшке спокойной
- обязательно следить за тем, чтобы не
было боли(питание , вода, массаж)

Как заподозрить аллергию на питание ?

У малышей часто возникает на молочные продукты, орехи, яйца



На что обратить внимание ?



- Кожа(сыпь, покраснение, шелушение , зуд)
- Со стороны ЖКТ (срыгивания, слизистый или жидкий стул , колики , вздутие)
- Со стороны дыхательной системы : насморк, кашель
- Общее состояние: плохой сон, беспокойство

Советы маме:

- Дневник питания (что ест ребенок и реакцию)
- Следить за общим состоянием ребенка

Пример дневника:

Дата	Время приема пищи	Продукты	Количество	Изменения		
				Кожных покровов (зуд, сыпь, отеки)	Органов пищеварения (срыгивание, рвота, боль в животе, жидкий стул)	Органов дыхания (насморк, кашель, затруднение дыхания)
26.09	9.00	Гречневая каша	200 г	9.20 — зуд, сыпь на щечках	9.30 — боль в животе 9.45 — жидкий стул	—
		Молоко	100 мл			
		Сливочное масло	10 г			
		Яблоко	1 шт.			

Расчет питания



Суточный объем пищи рассчитывают по формуле Гейбнера- Черни :

- от 2 до 6 нед - $1/5$ массы тела
- от 2 мес до 4 мес- $1/6$ массы тела
- от 4 мес до 6 мес - $1/7$ массы тела
- от 6 мес до 9 мес - $1/8$ массы тела
- Для ребенка до 1 года надо не более 1000-1100 мл

Например : ребенку 4 мес , масса тела = 6000 г
Объем пищи на сутки = $6000: 6=1000$ мл

Для детей в возрасте до 10 дней :

Суточный объем молока или смеси= 2% от массы тела при рождении x n, где n – день жизни новорожденного ребенка.

Пример: ребенок 3000 г, 5 дней жизни

Объем питания в сутки = 3000 г x 2% = 60 г

60 г X 5 дней = 300 г смеси в сутки

Объем 1 кормления = объем питания в сутки / количество кормлений в сутки, например, при 6-разовом питании = 300 г : 6 = 53 - 55 г.

Введение прикорма

Прикорм – все продукты кроме грудного молока и детских молочных смесей, дополняющие рацион пищевыми веществами, необходимыми для обеспечения дальнейшего роста и развития ребенка.



Прикорм целесообразно вводить в возрасте 5-6 мес.

- Введение нового продукта начинают с небольшого количества, постепенно (за 5-7 дней) увеличивают до объема, рекомендованного в данном возрасте;
- Новый продукт (блюдо) следует давать в первой половине дня для того, чтобы отметить возможную реакцию на его введение;
- Каши, овощные и фруктовые пюре следует вводить, начиная с монокомпонентных продуктов, постепенно добавляя другие продукты данной группы

- В возрасте 9-10 мес.
гомогенизированные и пюреобразные продукты следует постепенно заменить на мелкоизмельченные.
- В качестве первого прикорма назначается овощное пюре или каша в зависимости от состояния здоровья, нутритивного статуса и функционального состояния пищеварительной системы ребенка (детям со сниженной массой тела, учащенным стулом в качестве первого прикорма вводятся каши. при избыточной массе тела и запорах — овощное пюре).

Сроки введения прикормов детям первого года жизни

Прикормы	4-6 мес	7 мес	8 мес	9-12 мес
Каша	10-150	150	180	200
Овощ. пюре	10-150	170	180	200
Фр.сок	5-60	70	80	90-100
Фр. пюре	5-60	70	80	90-100
Желток	-	1/4	1/2	1/2
Мясное пюре (с 6 мес.)	5-30	30	50	60-70
Творог (с 6 мес.)	10-40	40	40	50
Кефир	-	-	200	200
Сухари, печенье	-	-	3-5	10-15
Хлеб пшенич.	-	-	5	10
Рыба	-	-	-	30-60
Раст. масло	1-3	5	5	6
Слив. масло	1-4	4	5	6

Зачем нужна вакцинация и как ПОДГОТОВИТЬСЯ

Вакцины защищают ребенка от
ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ (корь,
скарлатина, коклюш, полиомиелит,
дифтерия)

Вакцинированный
малыш легче переносит
инфекции или вовсе не
заболевает



Как подготовиться?

- Убедиться, что ребенок здоров(нет кашля, насморка, температуры)
- Сообщить врачу о хронических заболеваниях малыша или аллергиях)

Реакции на прививки : норма и опасность !

Норма:

- легкое повышение температуры тела до 38 гр
- покраснение или уплотнение в месте введения вакцины
- снижение аппетита
- плаксивость

Опасность :

- температура 39 и выше
- сильный отек на месте введения вакцины
- затрудненное дыхание
- судороги

Что делать , если перед вакцинацией ребенок заболел?

- При температуре, кашле и насморке или обострении хронических заболеваний вакцинацию откладывают до полного выздоровления
- Если легкие проявления решение о вакцинации принимает врач

Нормы развития по месяцам

Физическое развитие ребенка до года

1-2 мес.	Лежа на животе, пытается поднимать и удерживать голову
2-3 мес.	Удерживает голову вертикально на руках у взрослого
4 мес.	При поддержке под мышки крепко упирается о твердую опору ногами
5 мес.	Переворачивается со спины на живот
6 мес.	Переворачивается с живота на спину
6-8 мес.	Сначала передвигается, переставляя руки и подползая, а затем ползает на четвереньках
7-8 мес.	Учится самостоятельно садиться, сидеть и ложиться
8-9 мес.	Держась за опору, сам встает, стоит, опускается и переступает
10 мес.	Идет с поддержкой за обе руки
11 мес.	Стоит без поддержки и делает первые самостоятельные шаги
11-16 мес.	Ходит самостоятельно

Красные флаги по развитию

Возраст	Что должно быть	Повод для врача
0-3 мес	реакция на звук, зрительный контакт , улыбка	нет реакции на громкий звук, не фиксирует взгляд, нет улыбки
4-6 мес	держит голову , тянется к предметам	не держит голову, не тянется к предметам
6-9 мес	сидит , лепечет	не сидит , нет лепета
12 мес	понимает простые слова , сидит с опорой	не встает с опорой , нет слов
18 мес	ходит, говорит больше 6-10 слов	не ходит , нет слов

Первая аптечка малыша

Минимум , который должен быть дома у
родителей с младенцами



Жаропонижающие средства :

- Парацетамол (свечи, сироп)
- Ибупрофен (сироп)

Физ.раствор (или Аквамарис)

Для промывания носа, увлажнения слизистой

Назальный аспиратор (соплеотсос)

Антигистаминные (при аллергии , зуде, укусах насекомых, иногда-перед прививкой)

Фенистил капли - с 1 мес

Пробиотики (при дисбактериозе или же после антибиотиков)

Например , Биогая или Энтерожермина

Регидратационные растворы(Регидрон, Хумана Электролит)

Антисептики и уход за кожей : Хлоргексидин, Бепантен , бриллиантовый зеленый

Что делать при удушье

- Ребенок не может дышать или кашлять
 - Лицо краснеет либо синеет
 - Не может заплакать
-
- Положить ребенка лицом вниз к себе на предплечье, голова ниже туловища
 - Сделать 5 легких ударов ладонью между лопатками
 - Если предмет не вышел, то перевернуть на спину , сделать 5 нажатий 2-мя пальцами на грудь
 - Чередовать удары и нажатия , пока дыхание не восстановится



Если же малыш старше 1 года:

Если откашливается, то поощряем кашель

Если не может дышать, то встаем сзади и обхватываем руками талию

Сделать прием Геймлиха: резко надавливаем кулаком под ребрами вниз и внутрь (5 раз)

Оказание помощи ребенку старше 1 года

Удары по спине для удаления инородного тела из дыхательных путей ребенка



Прием Геймлиха для удаления инородного тела из дыхательных путей задыхающегося ребенка более старшего возраста.





Приём Геймлиха



Аллергическая реакция (от крапивницы до анафилаксии)

Степень реакции	Как проявляется	Что делать маме
Легкая	сыпь, пятна, зуд легкий насморк, слезотечение	убрать аллерген, дать антигистамин(супрастин либо фенистил), наблюдать
Средняя	выраженная сыпь по всему телу, отек век, губ, рвота, боли в животе, кашель	срочно обратиться к врачу, дать антигистамин, наблюдать до приезда
Тяжелая	отек лица, губ, языка, одышка, падение давления, потеря сознания	Немедленно вызвать скорую, уложить ребенка, приподнять ноги , контроль дыхания

Ушибы, падения , ожоги



При ушибах приложить
холод, дать покой,
обезболивающее либо
внутри, либо в виде мази



Оценить сознание, нет ли
рвоты или тошноты,
судорог, деформации
конечностей.
При любом из
перечисленных -в
приемный покой больницы



- При ожоге охладить место под прохладной водой
- Пузыри не прокалывать
- Можно наложить стерильную повязку
- При ожоге лица , большой площади срочно в БОЛЬНИЦУ!

Грудное вскармливание : как понять , что ребенку хватает молока

- Малыш сосет активно ,
после кормления спокойный
- Регулярный стул
- Хорошая прибавка в весе



Признаки нехватки :

- Плохая прибавка в весе
- Постоянное беспокойство
ребенка
- Нерегулярный стул и
мочеиспускание

Положения при кормлении :

Положение ребенка во время кормления грудью



Ребенок приложен к груди правильно

Он находится так близко, что его подбородок касается груди матери, рот широко раскрыт, нижняя губа вывернута наружу. Вы можете видеть большую часть ареолы над ртом и меньшую снизу.



Ребенок неправильно приложен

Он расположен далеко и его подбородок не касается груди, рот открыт нешироко и губы вытянуты вперед. Большая часть ареолы видна за пределами рта.



ПОЗА
«КОЛЫБЕЛЬКА»



ПОЗА «ПЕРЕКРЕСТНАЯ
КОЛЫБЕЛЬКА»



ПОЗА «ЗАХВАТ
МЯЧА»



КОРМЛЕНИЕ
ПОЛУЛЕЖА



ПОЗА «ЛЕЖА
НА БОКУ»

Трещина сосков :

поправить позу при кормлении ,
использовать заживляющие крема(
декспантенол)

Лактостаз(застой молока) :

сопровождается уплотнением груди,
болью

чаще прикладывать малыша, делать
мягкий массаж к соску

Мастит (воспаление):

сопровождается выраженной болью,
повышением температуры, ознобом,
срочно обратиться к врачу

Что спросить у врача



1. Диагноз(что конкретно или хотя бы предположительно)
2. Причина заболевания
3. Что можно ожидать дома , может появление каких-то дополнительных симптомов
4. Лечение (какие лекарства, насколько долгое)
5. Чего лучше не делать, чтобы не навредить
6. Уточнить когда повторный осмотр

Нормы сна по возрасту

 Возраст (ПДР)	 Всего сна в сутки	 Дневной сон	 Ночной сон
0-2 мес.	17-20 ч.	8-9 ч.	7-10 ч.
2-4 мес.	14-16 ч.	4-5 ч.	9-10 ч.
4-6 мес.	14-15 ч.	4-5 ч.	10 ч.
6-12 мес.	13-14 ч.	2,5-4 ч.	11-12 ч.
12-18 мес.	13-14 ч.	2-3 ч.	11-12 ч.
1,5-2,5 года	12-13 ч.	1,5-2,5 ч.	10,5-11 ч.
3-4 года	11-12 ч.	0-1,5 ч.	10,5-11 ч.
5 лет	10,5-11 ч.	-	10,5-11 ч.

Как наладить режим сна у малыша ?

- Купание в теплой воде
 - Легкий массаж перед сном
 - Кормление
 - На фон можно поставить источники белого шума
-
- Стараться укладывать малыша в одно и то же время
 - Обеспечить оптимальную температуру в комнате
 - Убрать визуальный шум